

**Brit Tammiste***sotsiaalministeeriumi erivajadustega laste poliitika juht*

Rehabilitatsiooniteenused peaksid olema vajaduse järgi kättesaadavad ja rohkem seotud tervishoiuvaldkonnaga

Praegust rehabilitatsioonisüsteemi on vaja korrastada, et inimesele oleks tema vajadustele vastav kvaliteetne teenus lihtsalt ja loogiliselt kättesaadav, spetsialiste kasutatakse seal, kus sellest kõige rohkem kasu on ning hinnatakse ka teenuse tulemuslikkust.

Täna peab terviseseisundist tingitud funktsioneerimisvõime piirangutega inimene orienteeruma süsteemis, kus riik korraldab kaht teenust, mille nimetuses on sõna „rehabilitatsioon“. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust (SRT) korraldab sotsiaalkindlustusamet, tööalast rehabilitatsiooni (TRT) töötukassa. Kummagi rehabilitatsiooniteenuse praegune eesmärk on näha jooniselt lk 20: TRT on suunatud tööealistele, eesmärk on toetada tööelus osalemist, SRT eesmärk on toetada puudega või piiratud töövõimega inimese toimetulekut igapäevaeluga. Mõlemal teenusel on ühised nõuded, missugused spetsialistid peavad ja võivad kuuluda rehabilitatsiooniteenuse meeskonda.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni sihtrühmad on järgmised:

- kuni 15-aastased puudega lapsed ja kuni 18-aastased mitmekülgse abivajadusega lapsed, keda on teenusele suunanud kohalik omavalitsus;
- 16-aastased ja vanemad inimesed: puudega, osalise töövõime (kes ei õpi ega tööta ega ole registreeritud töötuna) või puuduva töövõimega tööealised (alates 16. eluaastast kuni pensioniea saabumiseni), kellel on tuvastatud SRT vajadus, sh psüühikahäirega tööealised, ning puudega vanaduspensionialised.

Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse puudega, püsiva töövõimetusega või osalise

SRT eesmärk	Rehabilitatsiooniteenuse meeskonnas on vähemalt kolm spetsialisti	TRT eesmärk
Teenust osutatakse vähemalt ühe järgmise eesmärgi täitmiseks: 1) igapäevaelu valdkonnas suurendada motivatsiooni ja valmisolekut jõukohaseks osalemiseks kogukonna tegevustes, arendada kognitiivseid ja füüsilisi võimeid ning õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, mille tulemusena inimene elab võimalikult iseseisvalt; 2) õppimise valdkonnas pakkuda õppeprotsessis vajalikku tuge, mille tulemusel inimene omandab võimetekohase hariduse või täiendavad tööks vajalikud oskused; 3) suhtlemise ja vaba aja valdkonnas suurendada eneseteadvust, arendada eneseregulatsiooni, suhtlemis- ja koostööoskusi, mille tulemusel inimene osaleb võimetekohaselt ühiskonnas; 4) töövõime eelduste arendamise valdkonnas arendada isiku valmisolekut võimetekohasele tööle asumiseks. (SHS § 62. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamine)	Arst Õde Sotsiaaltöötaja* Psühholoog Füsioterapeut Logopeed Tegevusterapeut Muusikaterapeut Loovterapeut Eripedagoog Rehabilitatsioonimeeskonda võib kaasata ka kogemusnõustaja** (SHS § 62. Nõuded rehabilitatsioonimeeskonnale) * kohustuslik meeskonna liige ** lisaks kolmele nõutud erinevale spetsialistile	Töölane rehabilitatsioon on isiku tööeluks ettevalmistamiseks, tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks osutatav tööturuteenus, mis seisneb sotsiaalhoolekande seaduse § 57 alusel kehtestatud rehabiliteerivates tegevustes. (Tööturuteenuste ja -toetuste seadus § 23¹) SHS § 57. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate selliste teenuste loetelu ja hinna, mille eest tasu maksmise kohustuse võtab riik üle, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

Joonis. SRT ja TRT eesmärgid praegu kehtivates seadustes ning rehabilitatsioonimeeskonna võimalike spetsialistide loetelu

töövõimega tööealisele inimesele, kes töötab, õpib, on ettevõtja või on töötuna registreeritud. Alates 2024. aastast on uue tööturumeetmete seaduse kohaselt ka puuduva töövõimega töötavatel inimestel võimalik saada TRT-d. Teenuse osutamist jätkatakse töövõime toetamise tööturumeetme osana ja selle korraldus on sätestatud tööhõiveprogrammis aastateks 2024–2029.

Praeguse korralduse probleemid

Uuringud (nt Tamm jt 2021) on näidanud, et praeguses rehabilitatsioonisüsteemis on inimesel keeruline orienteeruda ja teenused ei ole sageli kooskõlas tegeliku abivajadusega. Õigus sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele ei olene otseselt inimese vajadustest.

Näiteks ei jõua teenusele osa inimesi, kes vajaksid kompleksset rehabiliteerivat sekumist: lapsed ja täiskasvanud, kellel ei ole puuet, kuid kellel on tegutsemis- ja osaluspiirangud. Selline korraldus võib tingida teenusele jõudmise alles siis, kui abivajadus on süvenenud ja seetõttu on vaja spetsiifilisi ning suuremas mahus teenuseid. On oluline, et vajadustele vastavat teenust saaks inimene siis, kui abivajadust märgatakse ja vajadust hinnatakse kokkulepitud alustel, et abivajaduse süvenemist ennetada. Samuti ei ole praeguse teenuse korralduse juures selge, millal peaks inimene teenuselt väljuma.

Teenustena osutatakse ka tervishoiu ja hariduse spetsialistide tugiteenuseid, mistõttu on inimese vaatest ebaselge, mis on SRT ja TRT lisandväärtus.

Mõlema rehabilitatsiooniteenuse eelduseks on kombineeritud kompleksteenuse vajadus – üksikteenuste vajadus peaks saama kaetud muul viisil. Eri spetsialistide teenuste osatähtsus, mida osutatakse sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni raames, on siht- ja vanuserühmiti erinev, mida kinnitavad sotsiaalkindlustusameti ja töötukassa 2022. aasta andmed.

- Lastele pakutakse SRT osana teenustundide arvu järgi kõige rohkem eripedagoogi (21%), psühholoogi (19%) ja logopeedi (12%) individuaalteenust.
- Puudega, osalise või puuduva töövõimega psüühikahäirega tööealiste siht- rühmas moodustab peaaegu neljandiku teenustundide mahust psühholoogi individuaalteenus (koos psühholoogi grupiteenusega peaaegu 30%), järgnevad sotsiaaltöötaja (20%) ja tegevusterapeudi (12%) individuaal- ning grupiteenused.
- Puudega, osalise või puuduva töövõimega tööealiste ja vanaduspensioneeriliste seas on samuti psühholoogi individuaalteenus kõige rohkem kasutatud SRT-teenus (22% teenustundide mahust).

Arvestades, et 2023. aasta oktoobrist on tervishoiu spetsialistide loetellu lisandunud füsioterapeut, logopeed ja kliiniline psühholoog, on tervishoiuteenuste katus rehabilitatsiooniteenustega kaalukas. Tervishoiuspetsialistid osutavad rehabilitatsiooni osana teenuseid, mida tavapäraselt pakutakse ka tervisekassa rahastatava tervishoiuteenustena. Hariduse tugispetsialistide teenused, nt eripedagoogi teenus, on sellised, mida lastel peaks olema võimalik saada ka haridussüsteemi kaudu. SRT ja TRT osana teenuste osutamine, mis kattuvad tervise- ja haridusvaldkonna teenustega, on ebamõistlik ja vahel dubleeriv vahendite kasutamine ning tekitab

segadust nii teenuse saajate kui ka osutajate hulgas.

Ümberkorraldustega soovitakse samade spetsialistide teenused ka üksikteenustena kättesaadavamaks teha tervise- või haridusvaldkonna ning kohaliku omavalitsuse (KOV) kaudu, et inimeste kompleksse abivajaduse kujunemist või süvenemist ennetada.

Sotsiaalvaldkond ei peaks olemuslikult täitma tervisevaldkonna teenuste ülesandeid ega spetsialistide tööaega kulutama seal, kus eraldi teenuse pakkumise põhjendatus sotsiaalvaldkonna korralduse kaudu puudub.

Väikeses Eestis on oluline suunata kvalifitseeritud spetsialistide tööaeg sinna, kus on inimese abivajaduse süvenemise ennetamine kõige enam võimalik ning teha seda ühtsetel alustel ja standardkvaliteediga teenuseid osutades. Kui inimesel on abi- ja toevajadus, mis ei tulene otseselt tema tervises seisundist ega ole suunatud funktsioneerimisvõime taastamisele või säilitamisele, on omal kohal KOV-i ja muud sotsiaalvaldkonna ning hariduse tugiteenused.

Rehabilitatsiooni osana teenuste osutamine, mis kattuvad tervise- ja haridusvaldkonna teenustega, on ebamõistlik.

Tähtis on, et inimene, kellel on tervises seisundist tingitud tegutsemis- ja osaluspiirang, saab tervisevajadusest lähtuvat tuge esmalt tervisevaldkonnast, olenemata sellest, kas tal on tuvastatud puude raskusaste või kas ja milline on tema töövõime hindamise otsus. Lapsele peaksid olema tema igapäevases õpikeskkonnas ennetavalt tagatud ka hariduse tugiteenused. Loodetavasti aitab alushariduses toetavate teenuste valiku

ja mahu rikastamisele ning süsteemsele vajaduspõhisele osutamisele kaasa koostatav alushariduse seaduse eelnõu.

Idealis peaks toimima selline korraldus, et spetsialistid märkavad inimese abivajadust, hindavad seda kokkulepitud kindla metoodika alusel ja suunavad vajaliku teenuseni või osutavad seda ilma, et inimene peaks erinevaid teenuseid eraldi taotlema. Seejuures on oluline, et pakutavad teenused lähtuvad inimese vajadustest, mis on kindlaks tehtud ja dokumenteeritud standardset keelt kasutades (rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni rakendamise võimalustest loe lähemalt Kairit Viidalepa artiklist, lk 30–34). Kvaliteetsete ja tulemuslike sekkumiste osutamiseks on Eestis vaja luua ja hoida pädevust, et suuta mõtestatult pakkuda tuge kõigile sihtrühmadele.

Võimalikud muudatused tulevikus

Eespool välja toodud probleemide tõttu on 2023. aasta lõpul ja 2024. aasta alguskuudel ametiasutuste ning huvikaitseorganisatsioonidega kooskõlastamisel sotsiaalministeeriumis koostatud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise väljatöötamise kavatsus (VTK). Selle eesmärk on muuta terviseeseisundist tuleneva abivajaduse leevendamiseks või seisundi halvenemise ennetamiseks vajalike teenuste osutamine inimesekeskseks ning vähem killustatuks nii, et vajadusele vastavate ja kvaliteetsete teenuste osutamine algatatakse seal, kus inimese abivajadus esmalt tuvastatakse. Üsna sageli on see tervishoiutöötaja ja tervisevaldkond. Ka praeguses süsteemis on inimesel sotsiaalse või tööalase rehabilitatsiooni teenusele jõudmise teekonnal vältimatult vaja kokku puutuda tervishoiuga: terviseandmeteta ei ole võimalik tuvastada puude raskusastet ega hinnata töövõimet.

Ka lastele hariduse tugiteenuste osutamiseks ja haridusliku erivajaduse hindamiseks kasutatakse nende terviseandmeid.

VTK-s pakutud lahendus on inimestele nende vajadustest lähtuvate terviseteenuste ühetaoliselt kättesaadavaks tegemine olenemata süsteemi sisenemise kohast ehk sellest, mis valdkonna spetsialisti juurde nad murega kõigepealt pöörduvad. Neil võimaldatakse kasutada nii praeguseid tervishoiuteenuseid (nt füsioteraapia, psühholoogiline ravi) kui ka tulevikus terviseteenuste loetellu eeldatavalt lisanduvaid teenuseid (loovteraapia, psühholoogiline nõustamine, tugigrupid vms).

VTK näeb ette ka terviseeseisundist tulenevate uute sekkumiste arendamist ja rahastamist praegusest rehabilitatsiooniteenuse eelarvest. Kavandatav muudatus on seotud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse väljatöötamiskavatsusega (esitatakse kooskõlastamiseks ja arvamuste saamiseks 2023. aasta neljandas kvartalis), mis näeb ette tervishoiuteenuste ehk raviteenuste kõrval teenuspaketi rikastamist terviseteenustega ehk ennetus- ja edendus- ning psühhosotsiaalsete teenustega.

Rehabilitatsioonis hõivatud spetsialistide teenused soovitakse teha kättesaadavamaks ka üksikteenustena tervise- või haridusvaldkonna ning kohaliku omavalitsuse kaudu.

Rehabilitatsiooniteenuste korraldamise VTK ettepanek näeb ette sotsiaalse rehabilitatsiooni ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse praegusel kujul osutamise lõpetamist, sh keh-tiva korra kehtetuks tunnistamist, ning tööalase rehabilitatsiooni (või edaspidi muu nimetusega teenuse) ümberkorraldamist.

VTK kohaselt pakub töötukassa ka tulevikus tööle aitamise ja töö jätkamise tuge, dubleerimata tervisevaldkonna teenuseid ning sekkumisi. Täpsemad muudatused töötatakse välja järgnevatel aastatel. Praegused rehabilitatsiooniteenuste osutajad, sh rehabilitatsioonimeeskondade spetsialistid, saavad edaspidi olla inimestele vajaduse järgi teenuse osutajad uutel alustel.

VTK näeb ette ka tervise seisundist tulenevate uute sekkumiste arendamist ja rahastamist praegusest rehabilitatsiooniteenuse eelarvest.

Uue teenuse korralduse ja rahastamise koostöös saab samm-sammult muudatusi kavandades välja arendada kompleksse abivajadusest lähtuva nn taastusabi, arengu ning funktsioneerimisvõime säilitamise toe kõigile selle vajajatele (s.t inimene ei pea siis enam teenuseid ise taotlema, teenuse saamine hakkab sõltuma tema seisundist ja olukorrast, mitte puudest või töövõimest).

Eestis on täna väga häid ja toimivaid rehabilitatsioonimeeskondi. Muudatuste

Mis on uue süsteemi keskmes?

- Inimese abivajaduse kiire väljaselgitamine ja ligipääs teenusele.
- Seisundit kirjeldavate andmete standardne dokumenteerimine.
- Kvaliteetne standarditud abi individuaalsetest vajadustest lähtudes.
- Tugimeetmete tagamine – rehabiliteerivate sekkumiste arendamine.
- Teenuste tulemuslikkuse hindamine.

kavandamisel peame silmas, et teenuse uus korraldus toetaks nende tööd: võimaldaks keskenduda teenuste sisulisele arendamisele ning vähendaks administratiivset koormust.

Sotsiaal- ja tervisevaldkonna loimimine on poliitikakujunduse siht, kus rehabilitatsiooniteenuste ümberkorraldamine saab olla üks teerajaja. Lähiaastatel seisab ees samm-sammult muudatuste täpsem kavandamine, arenduste ja muudatuste rakendamine, võttes arvesse teisi tervisevaldkonna arengusuundi ja võimalusi esmatasandi tervishoiu ning haiglavõrgu arendamisel. 

Viidatud allikas

Tamm, G., Kostabi, E., Trankmann, S., Remmik, M., ... Espenberg, S. (2021). *Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse tulemuslikkuse hindamise meetodika väljatöötamine ja tulemuslikkuse hindamine Sotsiaalkindlustusametile*. Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusüuringute keskus RAKE.